

Información Paciente

Nombre : Wendy Penelope Marchese Bascur
Edad : 42a 7m 25d
Dirección : Pje. Pitosporo 8494

Rut : 13.697.228-6
Fecha Nacto: 09/12/1979
Comuna : La Florida

N° Archivo : 2201692
Sexo : Femenino
Teléfono : 941527650

N° Epicrisis
314956

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Onco Hematología (5to Piso)

Fecha Ingreso : 13/07/2022 09:08

Días Estadía : 21

Unidad de Egreso : Onco Hematología (5to Piso)

Fecha Egreso : 03/08/2022 16:08

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

quimioterapia

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Debuta en enero 2016 con síndrome de vena cava superior.

TC TAP: Masa neoplásica pulmonar derecha con diseminación ganglionar cervicotorácico y linfangitis. Biopsia de linfonodo cervical (18/9/16) (FALP): N°50493-MM: Linfoma hodgkin clásico esclerosis nodular. Inició

1) 4 ciclos ABVD (16/11/16 al 04/03/2017)

PETCT: Respuesta parcial (no está indicado Deauville)

2) ESHAP 6 ciclos (03/04/17 al 05/10/17)

PETCT: Deauville 5

Biopsia de masa cervical por EBUS: Linfoma Hodgkin Clásico

TEP como hallazgo en taco (cavamed) desde 2019

3) Brentuximab (nov 2019): Sin respuesta

4) Nivolumab 7 dosis (20/3/2020) bisemanales: Remisión completa

Sin embargo no puede seguir costearo el tratamiento

PETCT (19/10/21): Masas hipermetabólicas pulmonares (SUVmax 21), adenopatías mediastínicas multicompartimentales y cadena mamaria (SUV max 4.4). hipermetabolismo esplénico (SUV 4.8), fractura ósea 8va costilla derecha y foco hipermetabólico 11° arco costal izquierdo.

Actualmente hospitalizado por neumonía grave asociado a covid

Del punto de vista hematológico la resolución del comité fue indicación de nivolumab aprobado en FDA el año 2016 para Hodgkin con R/R post trasplante y Brentuximab (J Clin Oncol 2018;36:1428-39).

Hospitalizada del 2/2/22 al 27/4/22 por

1) Neuomonia grave COVID19

2) VMI del 3/2 16/3

Fecha Epicrisis : 03/08/2022 16:03

Fecha Última Actualización: 03-08-2022 16:03:11

Página 2 de 3

- 3) TQT del 23/2 al 21/3
- 4) ITU por E.Coli
- 5) ITU por KPN BLEE
- 6) ITS asociada a CVC por S-epidermidis MR
- 7) DILI por voriconazol

29/6/22: I dosis de Nivolumab

13/7/22 II dosis de Nivolumab

Sin respuesta a terapia. Con crecimiento de masa mediastínica. Durante hospitalización evoluciona con síndrome de vena cava superior secundario a trombosis de VCS, en anticoagulación. Como complemento de estudio de cefalea se realiza PL y RM que descartan masas e infección de SNC. Además intercorre con ITS CVC por C. albicans + Burkholderia, completando tratamiento para la primera y, tras evaluación por infectología, se decide mantener tratamiento supresor para esta última.

Se planifica alta a domicilio en seguimiento por CCPP.

Diagnóstico de Egreso

Enfermedad De Hodgkin -
Linfoma Hodgkin - LH refractario
Síndrome de vena cava superior

Condición de Egreso Alta Domicilio

Egreso con Catéter Doble J:NO

HDE, afebril, sin apremio respiratorio.
Cefalea persistente, ahora moderada, con estudio negativo por RM y PL. Impresiona secundario a sd de vena cava superior.
Seguimiento en domicilio por cuidados paliativos.

Plan Post Alta

- 1.Reposo relativo
- 2.Regimen todo cocido
- 3.O2 para saturar >93%
- 4.Cotrimoxazol forte 2 comprimidos cada 12 horas a permanencia
- 5.Enoxaparina 60 mg cada 12 hrs SC
- 6.Prednisona 20 mg al día vo
- 7.Elcal D forte 1 comp al día VO
- 8.Risperidona 1mg cada 12 horas VO
- 9.Morfina 4 gotas cada 6 horas VO + 4 gotas SOS
- 10.Pregabalina 75mg en la noche VO
- 11.Domperidona 10 mg vo SOS
- 12.Omeprazol 20 mg al día vo
- 13.PEG 30g cada 8 h VO

Control en 2 semanas con Dr. Berkovits, pedir hora con este documento en CDT (dar prioridad, autorizado por Dr Berkovits).
Seguimiento por unidad de Cuidados Paliativos.
Registrar cambio de domicilio a Huecaturaba para poder dar continuidad a atenciones en domicilio.

Indicaciones

Tipo de Reposo : Relativo

Régimen Alimentario : Común

Medicamentos :

Controles

Fecha Epicrisis : 03/08/2022 16:03

Página 2 de 3

Fecha de Impresión : Lunes, 04 de Mayo de 2026 13:10

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL
DR. SÓTERO DEL RÍO
JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 03-08-2022 16:03:11

Página 3 de 3

INTERNO

Becado/Residente

José Ignacio Navarrete Zavala

Médico Tratante (Staff)